

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN IUD (ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM /AKDR)		
	No. Dokumen 330/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep	
Pengertian	Pemasangan IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah tindakan memasukkan alat kontrasepsi ke dalam kavum uteri untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan menerapkan prinsip pencegahan infeksi dan keselamatan pasien.		
Tujuan	1. Memberikan pelayanan kontrasepsi IUD yang aman, efektif, dan bermutu. 2. Menjamin keselamatan pasien selama tindakan pemasangan IUD. 3. Mencegah komplikasi akibat pemasangan IUD. 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan akreditasi nasional rumah sakit.		
Kebijakan	1. Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Keluarga Berencana. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit tentang Pelayanan Keluarga Berencana. 4. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit.		
Prosedur	A. PERALATAN DAN BAHAN 1. Set pemasangan IUD steril. 2. Spekulum vagina. 3. Tenakulum. 4. Sonde uterus. 5. Gunting benang. 6. Klem tampon. 7. Sarung tangan steril. 8. Larutan antiseptik. 9. Kasa steril. 10. Lampu pemeriksaan. 11. IUD dalam kemasan steril. 12. Tempat sampah medis dan safety box. 13. Formulir informed consent. B. PROSEDUR 1. Persiapan a. Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas. b. Jelaskan prosedur, manfaat, risiko, efek samping, dan alternatif kontrasepsi. c. Lakukan konseling KB dan pastikan pasien memahami tindakan yang akan dilakukan. d. Pastikan pasien memenuhi syarat pemasangan IUD dan tidak sedang hamil.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN IUD (ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM /AKDR)		
	No. Dokumen 330/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	e. Lakukan informed consent. f. Persiapkan alat dan bahan secara steril. g. Cuci tangan sesuai prosedur dan gunakan APD. C. Pelaksanaan 1. Minta pasien mengosongkan kandung kemih. 2. Posisikan pasien litotomi dan jaga privasi pasien. 3. Lakukan pemeriksaan bimanual untuk menentukan posisi, ukuran, dan arah uterus. 4. Pasang spekulum dan visualisasikan serviks. 5. Bersihkan serviks dan vagina dengan antiseptik. 6. Jepit serviks menggunakan tenakulum bila diperlukan. 7. Lakukan pengukuran kedalaman kavum uteri menggunakan sonde uterus secara hati-hati. 8. Buka kemasan IUD dengan teknik aseptik. 9. Masukkan IUD sesuai petunjuk pabrik dan teknik "no-touch" untuk mencegah kontaminasi. 10. Lepaskan IUD pada posisi yang sesuai di dalam kavum uteri. 11. Tarik inserter secara perlahan. 12. Potong benang IUD $\pm$ 3 cm dari ostium uteri eksternum. 13. Lepaskan tenakulum dan spekulum secara hati-hati. 14. Evaluasi adanya perdarahan atau keluhan segera. D. Pasca Tindakan 1. Observasi pasien selama 15–30 menit. 2. Jelaskan kemungkinan efek samping seperti kram ringan atau perdarahan bercak. 3. Ajarkan cara memeriksa benang IUD. 4. Berikan kartu kontrol IUD. 5. Anjurkan kembali segera bila terdapat: a. Nyeri perut hebat. b. Perdarahan banyak. c. Demam. d. Keputihan berbau. e. Benang tidak teraba atau IUD keluar. 6. Jadwalkan kunjungan ulang sesuai kebijakan rumah sakit.		
Unit Terkait	1. Poli kandungan 2. Ruang Maternitas		